



**SERVICE DE
NEUROLOGIE**
HÔPITAL HABIB BOURGUIBA
Sfax - Tunisie



كلية الطب بصفاقس
Faculté de médecine de Sfax

Les céphalées

Sujet : 16

Pr Ag DAOUD Sawsan, Pr FARHAT Nouha
Service de neurologie CHU Habib Bourguiba
sawsandaoud86@yahoo.com



Objectif 1

L'aura migraineuse:

- a. Est expliquée par la dépression corticale envahissante
- b. Est secondaire à une vasodilatation due à la libération de substance vasoactive
- c. Est secondaire à un dysfonctionnement cortical transitoire
- d. Est secondaire à une baisse transitoire du débit sanguin cérébral
- e. Est caractérisé par un dysfonctionnement cérébral transitoire du à des variations ioniques

Réponses: a-c-d-e



Objectif 1

Les céphalées migraineuses:

- a. sont secondaires à une vasodilatation due à la libération de substance vasoactive
- b. Sont la conséquence de la stimulation des nocicepteurs trigéminaux des méninges
- c. sont secondaires à une baisse transitoire du débit sanguin cérébral
- d. Sont associées à une inflammation des vaisseaux responsable d'une libération de substances algogènes
- e. Sont caractérisées par un déficit du neuropeptide CGRP

Réponses: a-b-d



Objectif 2



Les diagnostics à évoquer devant des céphalées brutales :

- a. Hémorragie méningée
- b. Dissection des vaisseaux du cou
- c. Un processus expansif intracrânien
- d. Une maladie de Horton
- e. Une méningite

Réponses: a-b-e





Objectif 2



Les diagnostics à évoquer devant des céphalées brutales :

- a. Hémorragie méningée**
- b. Dissection des vaisseaux du cou**
- c. Un processus expansif intracrânien
- d. Une maladie de Horton
- e. Une méningite**

Réponses: a-b-e





Objectif 2



L'hémorragie méningée doit être évoquée devant:

- a. Un contexte traumatique
- b. Des céphalées brutales et intenses
- c. Une fièvre
- d. Un syndrome de Claude Bernard Horner
- e. Un syndrome méningé

Réponses: b-e





Objectif 2

Les examens complémentaires qui contribuent au diagnostic d'une hémorragie sous arachnoïdienne sont:

- a. Une TDM cérébrale avec injection de produit de contraste
- b. Une TDM cérébrale sans injection de produit de contraste
- c. Une IRM cérébrale
- d. Un angioscanner des troncs supra aortiques
- e. Une ponction lombaire

Réponses: b-c-e



Objectif 2



Une dissection de l'artère carotide interne gauche peut se manifester par:

- a. Un déficit de l'hémicorps gauche
- b. Des céphalées brutales
- c. Des cervicalgies
- d. Un ptosis gauche
- e. Mydriase gauche

Réponses: b-c-d





Objectif 2

Au cours du syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, les céphalées sont caractérisées par :

- a. Un mode d'installation brutal
- b. Association à une mydriase modérée aréactive
- c. Une aggravation par l'effort physique
- d. Une aggravation en position tête penchée en avant et en position allongée
- e. L'association à des cervicalgies

Réponses: a-c





Objectif 2



L'anomalie à rechercher en cas de suspicion d'un syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible est :

- a. Un rétrécissement des artères cérébrales moyennes et antérieures
- b. Un aspect en chapelet des artères cérébrales sur les séquences ARM
- c. Une dilatation anévrysmale des artères cérébrales
- d. Un remaniement oedémato-hémorragique non systématisé
- e. Une thrombose d'une veine corticale

Réponse : b



Objectif 2



Les céphalées récentes d'aggravation progressive doivent faire évoquer:

- a. Un abcès cérébral
- b. Un glaucome à angle fermé
- c. Un hématome intra parenchymateux
- d. Une tumeur cérébrale
- e. Une tuberculose neuro-méningée

Réponse: a-d-e





Objectif 2

Les céphalées récentes d'aggravation progressive

Les causes infectieuses

- Méningite subaiguë
- Méningoencéphalite

HTIC subaiguë

- Tumeur
- Abscess
- Hématome sous-dural
- Hydrocéphalie
- HTIC idiopathique
- TVC

Maladie de Horton



Objectif 2

Madame M.A, âgée de 65 ans, présente des arthralgies, des céphalées récentes d'aggravation progressive. Elle rapporte la notion d'un épisode de cécité monoculaire transitoire il y a une semaine. Quel examen vous paraît le plus utile pour formuler une hypothèse diagnostique:

- a. Un scanner cérébral sans injection de produit de contraste
- b. La vitesse de sédimentation
- c. Une IRM cérébrale
- d. Un champ visuel
- e. Une imagerie des vaisseaux du cou

Réponse : b





Objectif 2



Les céphalées au cours de l'hypertension intracrânienne sont typiquement :

- a. De localisation diffuse en casque
- b. D'intensité modérée
- c. Aggravées par l'orthostatisme
- d. Maximales deuxième moitié de nuit
- e. Aggravées par l'effort

Réponse: a-d-e





Objectif 2

Concernant l'hypertension intracrânienne idiopathique:

- a. Les céphalées sont le premier symptôme
- b. L'absence d'œdème papillaire élimine le diagnostic
- c. La ponction lombaire présente un intérêt double
- d. L'imagerie cérébrale est systématique
- e. La corticothérapie est indiquée

Réponse: a-c-d





Objectif 4



Le diagnostic d'hypertension intracrânienne idiopathique est évoqué devant:

- a. Des céphalées rapidement progressives
- b. Un pic hypertensif
- c. Une diplopie
- d. L'obésité
- e. Un déficit moteur à bascule

Réponse : a-b-d





Objectif 2



La maladie de Horton doit être évoquée devant:

- a. L'âge supérieur à 60 ans
- b. Des céphalées brutales
- c. Des céphalées subaiguës d'aggravation progressive
- d. Altération de l'état général
- e. Une claudication de la mâchoire

Réponses : a-c-d-e





Objectif 2



Les céphalées au cours de la maladie de Horton sont:

- a. Episodique
- b. Lancinantes
- c. De localisation temporale
- d. Exacerbées par l'effort
- e. Brutale

Réponses : b-c





Objectif 4



Le diagnostic de certitude de la maladie de Horton repose sur :

- a. L'abolition du pouls temporal
- b. La présence d'une artérite gigantocellulaire sur la biopsie des artères temporales
- c. Une vitesse de sédimentation accélérée
- d. Une CRP positive
- e. La bonne réponse aux corticoïdes

Réponse: b





Objectif 2



Le diagnostic de thrombose veineuse cérébrale doit être évoqué devant:

- a. Un contexte de post partum
- b. Des céphalées récentes
- c. Des signes focaux à bascule
- d. Un déficit neurologique systématisé
- e. Une claudication douloureuse de la mâchoire

Réponses : a-b-c





Objectif 3



Devant des céphalées chroniques épisodiques on évoque

- a. Les malformations artério-veineuses
- b. La maladie de Horton
- c. La migraine
- d. Les algies vasculaires de la face
- e. L'hypotension intracrânienne

Réponses : a-c-d





Objectif 3



Devant des céphalées chroniques continues on évoque

- a. Les malformations artério-veineuses
- b. Les céphalées de tension
- c. Céphalées par abus d'antalgiques
- d. Phéochromocytome
- e. L'hypotension intracrânienne

Réponses : b-c





Objectif 2

Les céphalées chroniques épisodiques

Primaires

- **Migraine**
- **Algie vasculaire de la face**
- **Névralgie du trijumeau**

Secondaires

- **Malformation artérioveineuse**
- **Phéochromocytome**



Objectif 2

Les céphalées chroniques continues

Primaires

- Céphalées de tension
- Céphalées post-traumatiques
- Céphalées par abus d'antalgiques
- Cervicalgies chroniques

Secondaires

- Céphalées d'origine diverse (hyperviscosité sanguine, insuffisance respiratoire...).
- Tumorale



Objectif 4

Devant des céphalées, les éléments qui orientent vers une urgence sont:

- a. Un début brutal
- b. Le terrain jeune
- c. L'association de signes généraux ou neurologiques focaux
- d. Aggravation progressive
- e. Contexte post traumatique

Réponses : a-c-d-e





Objectif 4



Mr M.A., âgé de 35 ans, sans ATCD pathologique particulier, consulte suite à l'installation aigue de céphalées depuis 4 jours avec notion de cervicalgies. Notion de traumatisme cervical avant l'installation du tableau.

A l'examen, le patient était apyrétique, TA: 120/85 mmHg avec présence de syndrome de Claude Bernard Horner. Le reste sans anomalies



Objectif 4



Question 1

Devant ces céphalées, quels sont les arguments en faveur d'une céphalée secondaire?

- a. L'âge jeune
- b. Le mode d'installation aigu
- c. Les cervicalgies
- d. Le contexte post traumatique
- e. La présence de signes autonomiques

Réponses : b-c-d-e





Objectif 4



Question 2

Devant ce tableau quel est le diagnostic le plus probable?

- a. Une thrombose veineuse cérébrale
- b. Un processus expansif intracrânien
- c. Une hémorragie méningée
- d. Un syndrome de vasoconstriction cérébrale transitoire
- e. Une dissection carotidienne

Réponses : e





Objectif 4



Question 3

Quel est l'examen complémentaire à demander en urgence?

- a. Une IRM cérébrale
- b. Un scanner cérébral avec injection de produit de contraste
- c. Une ponction lombaire
- d. Imagerie vasculaire cervicale
- e. Biologie (VS-CRP)

Réponses : d





Objectif 4



Mr H.B., âgé de 65 ans, aux ATCD d'HTA, dyslipidémie, consulte pour des céphalées chroniques évoluant depuis 7 mois d'aggravation progressive avec notion de flou visuel.

A l'examen, le patient était apyrétique, TA: 140/95 mmHg avec présence d'une hémiparésie gauche spastique, l'examen au fond d'œil à mis en évidence un œdème papillaire stade 2 bilatéral.



Objectif 4



Question 1

Devant ces céphalées, quels sont les arguments en faveur d'une céphalée secondaire?

- a. L'âge avancé
- b. Le sexe masculin
- c. Céphalée d'installation rapidement progressive
- d. Les signes de localisation à l'examen
- e. L'œdème papillaire au FO

Réponses : a-c-d-e





Objectif 4



Question 2

Devant ce tableau quel est le diagnostic le plus probable?

- a. Une thrombose veineuse cérébrale
- b. Un processus expansif intracrânien
- c. Une malformation artérioveineuse
- d. Un accident vasculaire cérébral hémorragique
- e. Céphalée de tension

Réponses : b





Objectif 4



Question 3

Quel examen complémentaire demander?

- a. Une IRM cérébrale
- b. Un scanner cérébral sans injection de produit de contraste
- c. Une ponction lombaire
- d. Imagerie vasculaire cervicale
- e. Une artériographie

Réponses : a





Objectif 4



Mr K.M., âgé de 41 ans, sans ATCD pathologiques particuliers, consulte pour des céphalées «explosives», d'emblée maximales, associées à des vomissements en jet, une photophobie et une phonophobie.

A l'examen, patient apyrétique, obnubilé, couché en chien de fusil, dos tourné à la lumière. Il présentait une raideur de la nuque avec des ROT vifs aux 4 membres.



Objectif 4



Question 1

Devant ce tableau quel est le diagnostic le plus probable?

- a. Une thrombose veineuse cérébrale
- b. Une hémorragie méningée
- c. Une hydrocéphalie
- d. Une méningite
- e. Une crise de migraine

Réponses : b





Objectif 4



Question 2

Quel est l'examen complémentaire de première intention?

- a. Une artériographie
- b. Un scanner cérébral sans injection de produit de contraste
- c. Un scanner cérébral avec injection de produit de contraste
- d. Une ponction lombaire
- e. Imagerie vasculaire cervicale

Réponses : b





Objectif 4



Mme S.M., âgée de 32 ans, sans ATCD pathologique particulier, Enceinte 20 SA, consulte pour des céphalées holocrâniennes évoluant depuis 2 jours, réveillant la patiente la nuit, aggravées par l'effort de toux, associées à des vomissements en jet à l'acmé des céphalées.

A l'examen, la patiente était apyrétique, consciente coopérante, pas de déficit moteur ni sensitif. FO: œdème papillaire stade 2 bilatéral, limitation de l'abduction de l'œil droit. Reste de l'examen sans anomalies.



Objectif 4



Question 1

Devant ces céphalées, quel sont les arguments en faveur d'une céphalée secondaire?

- a. Le sexe
- b. Le contexte de grossesse
- c. Le syndrome d'hypertension intracrânienne
- d. L'œdème papillaire au FO
- e. L'âge

Réponses : b-c-d





Objectif 4



Question 2

Devant ce tableau quel est le diagnostic le plus probable?

- a. Une thrombose veineuse cérébrale
- b. Une méningite
- c. Une hémorragie méningée
- d. Une hydrocéphalie
- e. Une crise de migraine

Réponses : a





Objectif 4



Question 3

Quel examen complémentaire demander pour confirmer le diagnostic?

- a. Une IRM cérébrale
- b. Un scanner cérébral avec injection de produit de contraste
- c. Une ponction lombaire
- d. Imagerie vasculaire cervicale
- e. Un scanner sans injection de produit de contraste

GROSSESSE !!

Réponses : a



Objectif 5

Une patiente âgée de 31 ans consulte pour des céphalées évoluant depuis 7 ans. Ces céphalées sont épisodiques, pulsatiles, hémicrâniennes d'intensité modérée durant 12 à 48 heures. Elles sont associées à des nausées et parfois des vomissements, et s'améliorent par les antalgiques habituels



Objectif 5

QCM (1/3):

Devant ces céphalées, quel est le diagnostic le plus probable

- a. Une HTIC idiopathique
- b. Une migraine
- c. Algie vasculaire de la face
- d. Névralgie du trijumeau
- e. Syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible

Réponse : b





Objectif 5

Six mois après, la patiente consulte aux urgences pour des troubles visuels à type de lignes brisées scintillantes des 2 yeux ayant duré 30 minutes et suivies de céphalées décrites comme habituelles.

Elle est anxieuse et très algique





Objectif 5



QCM (2/3):

A quoi correspond cette symptomatologie visuelle

- a. Une kératite
- b. Une crise épileptique focale
- c. Une aura visuelle
- d. Un décollement rétinien
- e. Un accident ischémique transitoire

Réponse : c





Objectif 5



QCM (3/3):

Quelle est votre conduite à tenir

- a. Hospitaliser la patiente
- b. Demander une imagerie cérébrale
- c. Rassurer la patiente
- d. Prescrire un traitement antalgique
- e. Rechercher les facteurs déclenchants de la crise

Réponse : c-d-e





Objectif 5

La migraine sans aura:

- a. Peut toucher l'enfant
- b. Est plus fréquente que la migraine avec aura
- c. Nécessite un scanner avant de retenir le diagnostic
- d. Est caractérisée d'une durée variable de 4 à 72 heures
- e. Est associée à des anomalies à l'examen neurologique

Réponse : a-b-d





Objectif 5



L'aura migraineuse:

- a. Est caractérisée par un début brutal
- b. Est caractérisée par la survenue de signes neurologiques focaux
- c. Précède toujours les céphalées
- d. L'aura visuelle est la plus fréquente
- e. Disparaît en moins d'une heure

Réponses : b-d-e





Objectif 5



L'aura visuelle:

- a. Est le type d'aura le plus fréquent
- b. Les hallucinations visuelles sont le symptôme le plus fréquent
- c. Caractérise la migraine basilaire
- d. Dure de quelques minutes à une heure
- e. Peut être associée à une aura sensitive

Réponses : a-d-e





Objectif 5

L'aura sensitive:

- a. Est rare
- b. Est typiquement de localisation chéiro-orale
- c. Est caractérisée par la survenue de douleur de l'hémiface
- d. Les troubles sensitifs progressent selon une marche migraineuse
- e. Impose la réalisation d'une imagerie cérébrale

Réponses : b-d



Objectif 5



Les céphalées au cours de la migraine sont:

- a. Holocrânienne
- b. A type de décharges électriques
- c. Associées à des vomissements
- d. D'intensité modérée à intense
- e. Aggravées par l'effort physique

Réponse : c-d-e





Objectif 5

Les céphalées migraineuses sont caractérisées par :

- a. Localisation unilatérale, typiquement à bascule
- b. Caractère pulsatile
- c. Intensité légère
- d. Aggravation par les activités physiques de routine
- e. Association à une sono photo phobie

Réponse : a-b-d-e





Objectif 5

Pour retenir le diagnostic de migraine sans aura, les critères définis par l'international Headache Society ICHD 3 comprennent:

- a. Au moins 5 crises de céphalées durant chacune entre 4-72h
- b. Association obligatoire de sonophobie
- c. Association obligatoire de nausée et vomissement
- d. Des céphalées unilatérales, pulsatiles, d'intensité modérée à sévère
- e. Aggravation par l'activité quotidienne

Réponse : a-d-e



Migraine sans aura

- A- Au moins 5 crises répondant aux critères B et D
- B- Crise de céphalée durant 4 à 72 heures sans traitement
- C- Céphalée ayant au moins 2 des critères suivants
 - 1- Unilatéralité
 - 2- Pulsatile
 - 3- Caractère modérée ou sévère
 - 4- Aggravation par les activités physiques de routine /montée ou descente des escaliers
- D- Durant les céphalées au moins un des critères suivants
 - 1- Nausées et/ou vomissements
 - 2- Photophobie et sono phobie
- E- Pas mieux expliqué par un autre diagnostic de l'ICHD-3





Objectif 5

Chez un migraineux connu, quels sont les signes évocateurs de céphalées secondaires?

- a. Le changement du type des céphalées
- b. Le changement du côté de la douleur
- c. La résistance au traitement
- d. L'association à des vomissement
- e. Le caractère continu de la douleur

Réponse : a-c-e





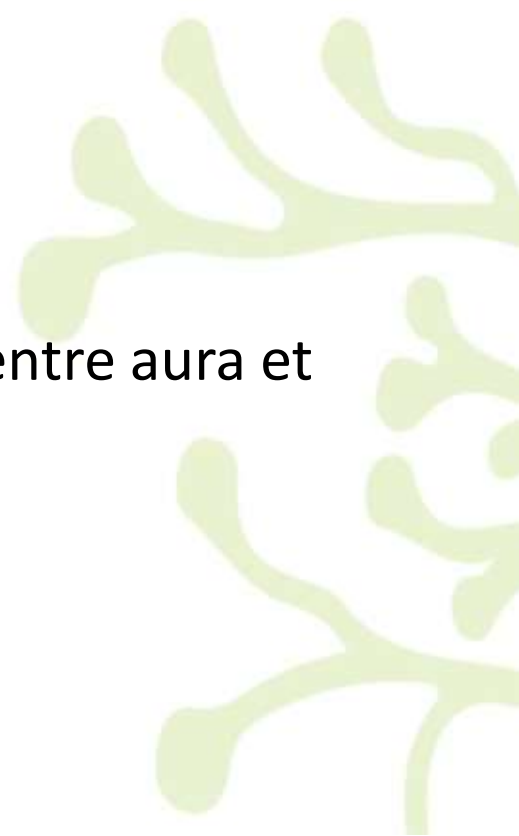
Objectif 5



L'aura migraineuse est caractérisée par :

- a. Un début progressif sur 1 à 2 minutes
- b. Une durée maximale de 60 minutes
- c. Une régression complète du symptôme
- d. Un intervalle libre maximum de 60 minutes entre aura et céphalée
- e. Survenue obligatoire de céphalées

Réponses : b-c-d





Migraine avec aura

A. Au moins deux crises répondant aux critères B et C

B. Au moins un symptôme entièrement réversible d'aura :

1. visuel
2. sensitif
3. parole et/ou langage
4. moteur
5. tronc cérébral
6. rétinien

C. Au moins trois des six caractéristiques suivantes :

1. au moins un symptôme d'aura se développe progressivement sur ≥ 5 minutes
2. deux ou plusieurs symptômes d'aura surviennent successivement
3. chaque symptôme d'aura dure 5-60 minutes
4. au moins un symptôme d'aura est unilatéral
5. au moins un symptôme d'aura est positif
6. l'aura est accompagnée, ou suivie dans les 60 minutes, d'une céphalée



Objectif 6



Un patient âgé de 51 ans, aux antécédents de diabète, consulte pour des céphalées atroces, orbitaires, toujours à droite à type d'arrachement depuis une semaine





Objectif 6



QCM 1/3

Les diagnostics à évoquer devant ce tableau sont:

- a. Une névralgie du trijumeau
- b. Un processus expansif intracrânien
- c. Une algie vasculaire de la face
- d. Une sinusite aigue
- e. Un glaucome à angle fermé

Réponse : c-e





Objectif 6

Le patient rapporte aussi que ces douleurs surviennent 3 fois par jours après les repas et sont associées à un larmoiement et une rougeur oculaire. Vous avez évoqué des crises d'algie vasculaire de la face





Objectif 6



QCM 2/3

Quels sont les autres arguments à rechercher pour renforcer votre hypothèse diagnostique:

- a. Une congestion nasale
- b. Une hyperesthésie du cuir chevelu
- c. Une rhinorrhée
- d. Un œdème palpébral homolatéral
- e. Une claudication de la mâchoire

Réponse : a-c-d





Objectif 6



QCM 3/3

Quelles sont les caractéristiques chronologiques des céphalées de l'algie vasculaire de la face:

- a. Evolution épisodique
- b. Survenue après les repas
- c. Horaire nocturne
- d. Durée de la crise moins de 10 minutes
- e. Survenue pluriquotidienne

Réponse : a-b-c-e





Objectif 6

L'algie vasculaire de la face :

- a. Peut être déclenchée par la prise d'alcool
- b. Caractérisée par des crises douloureuses très intenses
- c. Localisation de la douleur périorbitaire à bascule
- d. Durée de la crise de 4 à 72 heures
- e. Associée à des signes neurovégétatifs

Réponses : a-b-e





Objectif 6



L'algie vasculaire de la face :

- a. Touche essentiellement la femme jeune
- b. Evolue typiquement de façon épisodique
- c. Impose la réalisation d'une IRM cérébrale
- d. Peut se compliquer d'un AVC ischémique
- e. Peut être déclenchée par la stimulation de « la zone gâchette »

Réponses : b-c





Objectif 6

Névralgie du Trijumeau classique :

- a. Touche essentiellement la femme après 50 ans
- b. Est secondaire à un conflit vasculo-nerveux
- c. Est caractérisée par des crises douloureuses dans le territoire de la 5^{ème} paire crânienne
- d. Est associée à une hypoesthésie dans le territoire du trijumeau
- e. Peut être associée à une atteinte d'une autre paire crânienne

Réponses : a-b-c



Objectif 6

La douleur au cours de la névralgie classique du V est :

- a. Déclenchée par la stimulation « d'une zone gâchette »
- b. Toujours unilatérale
- c. Touche obligatoirement les 3 branches du V
- d. A type de décharges électriques
- e. Dure quelques minutes à une heure

Réponses : a-b-d





Objectif 6

La névralgie secondaire du V est :

- a. Toujours unilatérale
- b. Caractérisée par des douleurs fulgurantes très intenses
- c. Caractérisée par la persistance d'un fond douloureux entre les crises
- d. L'examen objective une hypoesthésie dans le territoire du V
- e. Peut être associée à une atteinte des autres paires crâniennes

Réponses : a-c-d-e



Objectif 6



L'algie vasculaire de la face :

- a. Est la céphalée primaire la plus douloureuse
- b. A une évolution saisonnière
- c. Le réflexe cornéen est aboli
- d. Sa crise a une durée plus courte que la migraine
- e. Est plus fréquente après l'âge de 50 ans

Réponse : a-b-c





Objectif 6

La céphalée de tension:

- a. Est caractérisée par la survenue de crises douloureuses unilatérale à type de décharges électriques
- b. Est une céphalée chronique permanente
- c. Est responsable d'un retentissement important sur la vie quotidienne
- d. Est aggravée par le stress et la fatigue
- e. Est associée à des nausées avec ou sans vomissement

Réponses : b-d



Objectif 6



Des céphalées associées à un syndrome de Claude Bernard Horner doivent faire évoquer:

- a. Une névralgie secondaire du trijumeau
- b. Une algie vasculaire de la face
- c. Une migraine basilaire
- d. Une thrombose veineuse cérébrale
- e. Une dissection des artères carotidiennes

Réponse : b-e



Bonne Chance!